



Психических расстройств за июль 2026

04.08.2026 / [Новости](#)



НОВОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ЗА ИЮЛЬ 2026

Автор: Черепкин Е. С.





топираматом, метформином и эксенатидом. Наиболее выраженный эффект показал семаглутид: среднее снижение массы тела составило около 11 кг; для лираглутида – около 5,4 кг, для топирамата и метформина – около 4 кг.

Клинически значимое снижение массы тела не менее чем на 5% отмечалось для семаглутида и метформина. Для ряда препаратов также наблюдались благоприятные изменения других метаболических показателей. Существенных сигналов по повышению частоты желудочно-кишечных нежелательных явлений или досрочного прекращения лечения между вмешательствами авторы не выявили.

Источник

Ускоренная ТМС не показала преимуществ в уменьшении суицидальных мыслей

В *Journal of Affective Disorders* опубликован систематический обзор и метаанализ, где оценивали эффективность, безопасность и приемлемость ускоренной транскраниальной магнитной стимуляции (аТМС) для снижения суицидальности при депрессивных расстройствах.

В обзор включили 13 исследований: 7 РКИ и 6 открытых исследований, всего 625 участников. В количественный метаанализ вошли 6 РКИ с 310 пациентами. Ускоренная ТМС не показала значимого преимущества перед sham-стимуляцией или стандартной ТМС по снижению суицидальных мыслей сразу после лечения или при последующем наблюдении. Также не выявлено значимого превосходства по депрессивной симптоматике.

По частоте ответа в отношении суицидальности отмечалась лишь статистически незначимая тенденция в пользу аТМС. Нежелательные явления в целом были легкими, но встречались чаще на фоне ускоренных протоколов; частота выбывания существенно не различалась.

Источник



годы. В анализ включили 2945 пациентов с впервые диагностированным биполярным расстройством; средний возраст составил 44,5 года, средняя длительность наблюдения – 3 года. Пациентов разделили на группы получавших и не получавших литий, а для контроля исходных различий применили взвешивание по обратной вероятности лечения.

Применение лития было связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний в целом: HR 0,38. Особенно выраженная ассоциация отмечалась для ишемической болезни сердца: HR 0,20. Для инсульта статистически значимой связи не выявили. В подгруппах снижение риска было наиболее заметным у пациентов старшего возраста, мужчин и людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми факторами риска.

Источник

Комбинация антидепрессанта и антипсихотика почти вдвое повышает вероятность улучшения при психотической депрессии

В *Journal of Affective Disorders* опубликован систематический обзор и парный метаанализ рандомизированных испытаний острой терапии психотической депрессии. В него вошли четыре исследования и пять сравнений. Сочетание антидепрессанта с антипсихотиком почти вдвое повышало вероятность клинического улучшения по сравнению с монотерапией: RR 1,93, 95% ДИ 1,53–2,43. Результат сохранялся при отдельной оценке ответа, RR 2,03, и ремиссии, RR 1,78.

Доказательная база включала сочетания амитриптилина с перфеназином, сертралина с оланзапином, флуоксетина с оланзапином и венлафаксина с кветиапином. В отдельных испытаниях амитриптилин с перфеназином превосходил каждый из препаратов в монотерапии, сертралин с оланзапином превосходил монотерапию оланзапином, а венлафаксин с кветиапином был эффективнее венлафаксина. Для комбинации флуоксетина с оланзапином положительный результат был получен в одном из двух параллельных испытаний. При этом



Источники

Мемантин не улучшил результаты терапии острой мании

В *BMC Psychiatry* опубликовано рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание, где оценивали эффективность и безопасность мемантина как аугментации при остром маниакальном эпизоде у пациентов с биполярным расстройством I типа.

Все участники одновременно получали стандартную терапию литием и оланзапином. Мемантин титровали с 5 до 20 мг/сут, длительность лечения составила 6 недель.

Выраженность мании по шкале мании Янга (YMRS) существенно снижалась в обеих группах, однако различий между мемантином и плацебо не выявили ни на 2-й, ни на 4-й, ни на 6-й неделе. Общее клиническое впечатление по CGI также не различалось между группами. Мемантин не показал значимого влияния и на периферические воспалительные маркеры, включая уровень лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов и нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение.

Все зарегистрированные нежелательные явления были легкими; умеренных или тяжелых событий не отмечено. Авторы делают вывод, что добавление мемантина к терапии литием и оланзапином не дает дополнительной симптоматической или биологической пользы при острой мании и не поддерживает его рутинное применение в этой ситуации.

Источник

КПТ лучше других психологических вмешательств изучена для уменьшения позитивных симптомов шизофрении



контроль, обычное лечение и поддерживающая терапия. Размер эффекта был небольшим или умеренным в зависимости от типа сравнения. При этом КПТ ассоциировалась с более высокой частотой выбывания по сравнению с обычным лечением.

Для других психологических вмешательств доказательная база была менее обширной. Авторы отмечают, что уверенность в оценках варьировала от умеренной до очень низкой, однако результаты в целом сохранялись в анализах чувствительности, включая поправки на исследовательскую приверженность и ослепление оценивающих.

Источник

Уровни лития выше 0,8 ммоль/л повышают риск нежелательных эффектов у пожилых пациентов

В *Bipolar Disorders* опубликован систематический обзор рабочей группы ISBD, посвященный безопасному и эффективному терапевтическому диапазону лития у пожилых пациентов с биполярным расстройством.

Авторы проанализировали исследования с 2017 года, где оценивали уровни лития в сыворотке у пациентов с биполярным расстройством в возрасте 60 лет и старше.

Средние или медианные уровни лития в исследованиях находились в диапазоне 0,47-0,67 ммоль/л. Уровни 0,82-1,00 ммоль/л были связаны с повышенной частотой нежелательных эффектов или ранними признаками токсичности, а уровни 1,20–1,25 ммоль/л расценивались как явно токсические. Наиболее важными факторами риска токсичности были снижение функции почек, полипрагмазия, а также совместное применение диуретиков, ингибиторов АПФ и НПВС.

Источник



первого года.

Внутрииндивидуальный дизайн позволил учесть постоянные индивидуальные факторы риска, однако наблюдательное исследование не доказывает причинную связь. Сахарный диабет определяли по назначению неинсулиновых сахароснижающих препаратов, поэтому часть случаев могла остаться неучтённой; влияние отдельных антипсихотиков также не оценивалось. Практический вывод остаётся ясным: метаболический мониторинг у детей и подростков следует начинать вместе с антипсихотической терапией и продолжать после её завершения, особенно у девушек и подростков.

Источник

Транскраниальная стимуляция переменным током повысила частоту ответа при биполярной депрессии

В *Molecular Psychiatry* опубликовано рандомизированное двойное слепое sham-контролируемое испытание, где оценивали эффективность и безопасность транскраниальной стимуляции переменным током (tACS) как добавочной терапии при биполярной депрессии.

В исследование включили 60 пациентов, которых рандомизировали на активную 10-Гц tACS или sham-стимуляцию на фоне терапии литием 500 мг/сут. Стимуляцию проводили дважды в день в течение 2 недель: всего 20 сеансов по 20 минут, билатерально над дорсолатеральной префронтальной корой.

На 2-й неделе клинический ответ по HAMD-17 чаще отмечался в группе активной tACS, чем в группе sham-стимуляции: 46,7% против 20,0%. На 4-й неделе преимущество также сохранялось: 70,0% против 43,3%. Активная стимуляция дополнительно ассоциировалась с большим снижением тревоги и нарушений сна, без ухудшения когнитивных показателей.



небольшой эффект при депрессии с неясной клинической значимостью

В *JAMA Network Open* опубликовано рандомизированное двойное слепое sham-контролируемое испытание, где оценивали транскраниальную импульсную стимуляцию левой дорсолатеральной префронтальной коры при большом депрессивном расстройстве.

В исследование включили 80 пациентов, рандомизированных 1:1 на активную или sham-стимуляцию. Участники получили 12 сеансов в течение 4 недель, по 1000 импульсов за сеанс. Основным исходом было изменение выраженности депрессии по MADRS после завершения курса.

Активная стимуляция показала статистически значимо большее снижение баллов MADRS по сравнению с sham-стимуляцией: средняя разница составила -4,19 балла. По HAMD-17 и PHQ-9 в обеих группах отмечалось улучшение, но различия между активной и sham-стимуляцией не достигли статистической значимости.

По данным функционально МРТ активная стимуляция усиливала функциональную связность между левой дорсолатеральной префронтальной корой и несколькими зонами, связанными с регуляцией настроения, включая орбитофронтальную, медиальную префронтальную и прегенуальную переднюю поясную кору. Лечение было безопасным и хорошо переносилось.

Источник

Материал подготовлен при поддержке психиатрической клиники
“Доктор САН” в Санкт-Петербурге (doctorsan.ru) +7 821 407-18-00

Перевод: Черепкин Е. С.

Составитель: Касьянова Е. Д.

PsyAndNeuro.ru

Психиатрия & Нейронауки

Главная
Все публикации
Диагностика
Терапия
Bekhterev AI

